Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 31ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810501

Processo nº 0069473-02.2024.8.17.2001

INTERESSADO (PGM): L. M. M. D. A.
REPRESENTANTE: MARCELA MUNIZ DE ANDRADE

ESPÓLIO - REQUERIDO: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Vistos...

Este processo corresponde a uma **Ação Cognitiva** aforada por **L.M.M.A.**, representada por sua genitora, através de advogado devidamente habilitado, em face da **UNIMED RECIFE SAÚDE SEGUROS S/A** (**UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO)**, igualmente qualificada.

Na inicial, consta pedido de obrigação de fazer, à guisa de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, oriunda do contrato (seguro/plano de saúde) firmado com a demandada, para compelir a ré a custear e autorizar *"os tratamentos de APLICADA EM ABA MULTIDISCIPLICAR COM ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM ÂBITO ESCOLAR, acompanhamento médico, por prazo indeterminado, conforme Laudo Médico incluso, a expensas da Ré, considerando o contrato com ela firmado, sendo certo que o pagamento integral deve ser realizado diretamente ao profissional ou clínica especializada"* - vide laudo de Id nº 174965030. Requer ainda o benefício da assistência judiciária gratuita.

Determinada a emenda de Id nº 175007899, a parte autora se manifestou nos termos do Id nº 175246044. Acostou a negativa de Id nº 175246053.

Concedida a tutela de urgência – Id nº 175337087 -, determinando que a ré "*custeie na rede credenciada ou, caso inexistente, integralmente e diretamente ao prestador fora da rede credenciada, o acompanhamento da autora com assistente terapêutico em sala de aula, nos exatos termos requeridos pelo médico assistente, por tempo indeterminado,* ***no prazo de 72 (setenta e duas) horas****, sob pena de incorrer em multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais)".*

Citada, a parte demandada, ofereceu resposta, em forma de contestação (Id nº 176967278), pugnando pela improcedência do pleito autoral, defendendo que: **a)** "***a Unimed Recife já autorizou a realização do tratamento da parte autora, mais precisamente quanto ao tratamento que possui cobertura contratual e legal, na Clínica Mundos*****"; b) "*****a Unimed Recife NÃO NEGOU O TRATAMENTO e que dispõe de profissionais aptos a prestar o tratamento prescrito ao autor,***

***apenas indeferindo o AT escolar, visto que, não possui cobertura contratual*"; c)** que eventual reembolso deve ser limitado aos valores do contrato; e **d)** "*A assistência terapêutica em ambientes escolar e domiciliar para aplicação do método ABA deve ser garantida pelas instituições responsáveis, conforme determina a legislação específica, não podendo ser transferida para as operadoras de planos de saúde*"**.**

O Representante do MP se manifestou no Id nº 178352457.

As partes foram intimadas para manifestar interesse em produzir novas provas - Id nº 179125346.

A parte demandada requereu a juntada de prova emprestada, bem como a expedição de ofícios ao Núcleo de Apoio Técnico do TJPE ou a realização de perícia médica e a expedição de ofício à ANS – cf. Id nº 179789734.

A parte autora, por sua vez, quedou-se inerte – cf. certidão de Id nº 184438893.

Foi o que entendi de importante a relatar.

Passo à motivação.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/2015, por não haver necessidade de dilação probatória, razão pela qual indefiro as provas requestadas pela parte demandada, eis que desinfluentes para o deslinde da questão especificamente tratada, como adiante se verá.

Inicialmente, a fim de sanar a omissão pretérita, *concedo o benefício da gratuidade judiciária. Ciente a parte demandante quanto ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.*

Cumpre destacar que os contratos de seguro/plano de saúde, por definição legal, encerram relação de consumo, portanto devem ser interpretados sob a ótica da legislação que lhe é própria, ainda que definidos ou regulamentados em textos outros. Tal entendimento foi ratificado pelo STJ através do enunciado da Súmula 608: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".

Nas relações de consumo, notadamente aquelas que se firmam mediante simples adesão de uma parte ao contrato previamente estabelecido pela outra, devem preponderar, sobre a letra fria do texto, a boa-fé dos contratantes e o equilíbrio contratual.

Importa ressaltar que a finalidade precípua do contrato de assistência médica entabulado com a ré é a manutenção da saúde dos contratantes, sendo significativo notar que a atividade desenvolvida pela ré não pode ser confundida com outras atividades econômicas, conquanto voltada para a questão da saúde, cujo valor jurídico não pode ser tratado como qualquer mercadoria.

Feitas tais considerações, passo a analisar o caso concreto trazido pelas partes.

Note-se que cerne da questão não está centrado em averiguar se a operadora de saúde demandada possui a obrigação de fornecer o tratamento prescrito à autora, portadora de TEA, na modalidade prescrita pelo médico assistente, com equipe multidisciplinar de reabilitação – vide laudo de Id nº 174965030 – ou se os profissionais credenciados são aptos a prestar o aludido tratamento, mas tão somente se verificar a correção da negativa de cobertura do assistente terapêutico.

Em sua contestação (Id nº 176967278), a ré defendeu expressamente não ter obrigatoriedade de custear o AT em sala de aula, ante a ausência de obrigatoriedade pelo rol da ANS e decisão do STJ.

Em primeiro lugar, é importante dizer que a Corte da Cidadania já consolidou entendimento no sentido de que a **"operadora de plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente(...)"** (AgInt no AREsp 1.072.960/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 8/9/2017).

Neste sentido, segue julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. **O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, embora a seguradora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura do plano de saúde, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional médico, de modo que, se a doença está acobertada pelo contrato, a operadora do plano de saúde não pode negar o procedimento terapêutico adequado.** Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1185690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

Em segundo lugar, para a temática em foco, a ANS editou o Comunicado 95/2022 sobre o tema: *"A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no uso das atribuições que lhe confere o inciso III, do art. 55, da Resolução Regimental nº 21, de 26 de janeiro de 2022, considerando a decisão proferida na 14ª Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, contida no processo SEI nº 33910.019120/2022-91, COMUNICA para todas as operadoras de planos de saúde que por determinação judicial ou por mera liberalidade, dentre outras hipóteses, já estiverem atendendo os beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e todos os beneficiários diagnosticados com CIDs que se referem aos Transtornos Globais do Desenvolvimento (CID-10 - F84) em determinada técnica/método/abordagem indicado pelo médico assistente, reconhecidos nacionalmente, tal como a ABA (Análise Aplicada do Comportamento), não poderão suspender o tratamento, sob pena de vir a configurar negativa de cobertura.".*

Em seguida, a ANS editou a **Resolução Normativa nº 539/2022**, que entrou em vigor em 1º de julho de 2022, ampliando as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, tornando obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicada pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha transtorno do espectro autista, **inclusive em ambiente escolar**, conforme disposto na Lei nº 12.764/2012 (Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), em seu art. 3º, I , II e parágrafo único.

Assim, o art. 6º da RN 465/2021 da ANS passou a vigorar acrescido do parágrafo 4º que dispõe:

§ 4º. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Ademais, **reitero aqui a fundamentação constante na tutela de urgência concedida (Id nº 175337087)**, uma vez que, **considerando a força vinculante do Incidente de Assunção de Competência (IAC 8) nº 0018952-81.2019.8.17.9000**, bem como o reconhecimento pelo STJ quanto a obrigatoriedade do custeio do tratamento multidisciplinar a afastar a taxatividade do rol da ANS, não há que se falar na exclusão de cobertura alegada pela ré.

Note-se que, somados aos precedentes supramencionados, se faz necessário ressaltar que, com a publicação da Lei 14.454/2022 que estabelece critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar**, o conceito de "rol taxativo" restou flexibilizado**, estando a recente orientação da ANS em harmonia com os ditames legais atuais.

Dito isso, as seguintes teses fixadas no precedente vinculante (IAC nº 08) são suficientes para afastar o tópico defensivo, senão vejamos: **Teses 1.0, 1.2 e 2.1.**

No mais, o **IAC** prevê a cobertura para acompanhante terapêutico quando de sua frequência a estabelecimento escolar, pois *a aplicação do método ABA em ambiente escolar e domiciliar é considerada parte do tratamento de saúde da criança com TEA – Transtorno do Espectro Autista, e, portanto, a sua cobertura é obrigatória pelos planos de saúde, desde que aplicadas por profissionais da área de saúde, conforme determina o art. 6º, da Resolução Normativa da ANS nº 465/2021*.

Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE HAPVIDA - TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR NOS TERMOS DO LAUDO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS DO PLANO DE SAÚDE EM NÚMERO SUFICIENTE PARA O EFETIVO ATENDIMENTO NA ÁREA TERRITORIAL DE COBERTURA - OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO ACOMPANHAMENTO NO ÂMBITO ESCOLAR E DOMICILIAR POR A.T. E DEMAIS TERAPIAS - ASSEGURADO O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS PELO AGRAVADO COM PROFISSIONAIS HABILITADOS - ADEQUAÇÃO AO IAC Nº 0018952-81.2019.8.17.9000 –- RECURSO DESPROVIDO POR UNANIMIDADE DOS VOTOS. (TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0002953-83.2022.8.17.9000, Rel. HUMBERTO COSTA VASCONCELOS JUNIOR, Gabinete do Des. Humberto Costa Vasconcelos Júnior (4ª CC), julgado em 08/05/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE LIMITES PARA SESSÕES POR ANO. RESOLUÇÃO Nº 469 DA ANS. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJPE. 1. A Seção Cível, no julgamento do IAC na apelação cível nº 0018952-81.2019.8.17.9000, assegurou, em caráter vinculante, ao portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA, beneficiário de contrato de assistência à saúde, com vigência anterior ou posterior à Lei nº 9.656/98 e independentemente do contrato ser adaptado ou não, cobertura integral, multidisciplinar e contínua, incluindo as chamadas terapias especiais (terapia ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, hidroterapia/fisioterapia aquática, equoterapia, psicopedagia), sem restrições quanto aos métodos terapêuticos (ABA, BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL), seja no ambiente domiciliar e escolar, tudo conforme laudo do médico assistente. 2. Quanto à cobertura no ambiente escolar, afigura-se relevante destacar que a responsabilidade do plano de saúde restringe-se ao assistente terapêutico, integrante da equipe multiprofissional e responsável pela aplicação da intervenção ABA. Valendo dizer, que o assistente terapêutico não se confunde com o acompanhante especializado em sala de aula a que alude o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012. Em outros termos, o acompanhante especializado em sala de aula é profissional de educação, atuando junto às crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em todos os ambientes, inclusive na escola. 5. Agravo de instrumento

improvido. (TJPE, Agravo de Instrumento 0014812-33.2021.8.17.9000, Rel. FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 15/10/2024).

Quanto a questão do reembolso nos limites do contrato, tenho a dizer que mantenho o entendimento declinado na concessão da tutela de urgência de custeio "*na rede credenciada ou, caso inexistente, integralmente e diretamente ao prestador fora da rede credenciada, o acompanhamento da autora com assistente terapêutico em sala de aula, nos exatos termos requeridos pelo médico assistente",* observando-se as **teses 1.3 e 2.2** do aludido IAC, restando, pois, procedente a obrigação de fazer, enquanto fundamentada em respectiva prescrição médica.

Relevante assinalar que existindo AT credenciado, caso a parte autora pretenda ser atendida fora da rede credenciada, o reembolso, caso previsto, se dará nos limites do contrato.

Por outro lado, o custeio de tratamento realizado fora da rede credenciada, em decorrência da inexistência de AT ou da inexistência de AT devidamente habilitado vinculado à operadora de saúde, deve se dar de modo integral, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Pernambuco:

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO PARCIAL NÃO CABÍVEL. CIRURGIA DE "TRAQUEOSTOMIA COM COLOCAÇÃO DE ÓRTESE TRAQUEAL". **AUSENCIA DE MÉDICO CREDENCIADO PELA OPERADORA. CABÍVEL O REEEMBOLSO TOTAL.** SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA. DANOS MORAIS. QUANTUM. R$ 3.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. **Não há que se falar em limitação da restituição dos honorários médicos ao disposto na tabela do contrato quando o procedimento só é realizado com médico não credenciado em virtude da inexistência de profissionais credenciados no plano para a realização do procedimento cirúrgico.** 2. Recurso improvido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 4832799 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 31/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2018).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. DEVER DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA DE LIMITES PARA SESSÕES POR ANO. RESOLUÇÃO Nº 469 DA ANS. PRECEDENTE VINCULANTE DO TJPE. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA APTA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. 1. A Seção Cível, no julgamento do IAC na apelação cível nº 0018952-81.2019.8.17.9000, assegurou, em caráter vinculante, ao portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA, beneficiário de contrato de assistência à saúde, com vigência anterior ou posterior à Lei nº 9.656/98 e independentemente do contrato ser adaptado ou não, cobertura integral, multidisciplinar e contínua, incluindo as chamadas terapias especiais (terapia ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, hidroterapia/fisioterapia aquática, equoterapia, psicopedagia), sem restrições quanto aos métodos terapêuticos (ABA, BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL), seja no ambiente domiciliar e escolar, tudo conforme laudo do médico assistente. 2. Quanto à cobertura no ambiente escolar, afigura-se relevante destacar que a responsabilidade do plano de saúde restringe-se ao assistente terapêutico, integrante da equipe multiprofissional e responsável pela aplicação da intervenção ABA. Valendo dizer, que o assistente terapêutico não se confunde com o acompanhante especializado em sala de aula a que alude o parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012. Em outros termos, o acompanhante especializado em sala de aula é profissional de educação, atuando junto às crianças especiais introduzidas no contexto escolar, enquanto que o acompanhante terapêutico, na condição de aplicador da ciência ABA, é profissional de saúde, integrante da equipe multiprofissional, responsável pelo acompanhamento diário do tratamento clínico/terapêutico da criança, em todos os ambientes, inclusive na escola. 3. Nos termos

da Resolução Normativa nº 469, de 09 de julho de 2021, não há limites de sessões para atender ao portador de autismo. 4. À toda evidência, cabe a empresa operadora do plano de saúde demonstrar que possui em sua rede referenciada clínica que assegure o tratamento indicado pelo médico assistente, com condições de seguir o plano terapêutico de modo integral, multidisciplinar e coordenado. 5. Na hipótese de não haver comprovação de existência de rede credenciada apta a realizar o tratamento de modo integral, multidisciplinar e coordenado, conforme prescrito pelo médico assistente, o reembolso deve ser realizado de forma integral. Precedentes do STJ. 6. Agravos de instrumento improvidos. Prejudicado o agravo interno. (TJPE, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0001230-97.2020.8.17.9000, Rel. BARTOLOMEU BUENO DE FREITAS MORAIS, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC), julgado em 24/05/2023).

Em tempo, registro, por oportuno, que no caso de inexistência de AT na rede credenciada, para o caso de eventual reembolso não há de ser observado o suposto obstáculo imposto no Resp nº 1959929-SP, uma vez que, considerando as peculiaridades do tratamento da patologia da autora, não se vislumbra a adequação do aludido entendimento da 3ª Turma do STJ por dois motivos: a) primeiro, porque caberá à parte autora proceder com o pedido administrativo e respectiva apresentação dos documentos pertinentes; e b) segundo, porque requerer a comprovação de quitação prévia, em casos de tratamento de autismo, é o mesmo de negar a cobertura, invibializando a realização do tratamento e contrariando o escopo do contrato firmado.

Logo, comprovada a realização do serviço médico coberto, a frequência do paciente nas sessões e o valor do tratamento através de notas fiscais, não há que se falar em necessidade da prévia apresentação de um comprovante de quitação de despesa com base em entendimento do STJ para um caso específico.

Por fim, cabe pontuar que, em *relação aos honorários advocatícios relacionados ao pedido de obrigação de fazer*, como a hipótese é de *tratamento continuado*, o percentual deve incidir sobre o valor da causa, visto que não mensurável no momento da fixação.

A respeito desse assunto, segue a transcrição:

EMENTA - RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE **TRATAMENTO**. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). PROVEITO ECONÔMICO IMENSURÁVEL. CRITÉRIO PARA O ARBITRAMENTO DOS **HONORÁRIOS** DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação cominatória c/c compensação por dano moral ajuizada em 17/10/2017, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/12/2019 e concluso ao gabinete em 19/11/2020. 2. O propósito recursal é decidir sobre a configuração do dano moral e o critério para fixação dos **honorários** advocatícios de sucumbência. 3. O descumprimento contratual, por parte da operadora de plano de saúde, que implica negativa ilegítima de cobertura para procedimento médico, somente enseja reparação a título de danos morais quando trouxer agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada do paciente. Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção, o título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado na compensação dos danos morais) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as condenações. 5. Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos **honorários** advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos **tratamentos continuados,** por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pela Segunda Seção, deve ser o do valor da causa. 6. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de **honorários**.

REsp 1904603 / RS - RECURSO ESPECIAL - 2020/0292148-7 – **RELATORA -** Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) - **ÓRGÃO JULGADOR -** T3 - TERCEIRA TURMA - **DATA DO JULGAMENTO -** 22/02/2022 - **DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE -** DJe 24/02/2022. (Sulinhei).

No entanto, considerando que o valor da causa, no presente caso, foi irrisório, os aludidos honorários devem ser fixados por equidade, entendendo essa magistrada ser suficiente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelo trabalho desenvolvido.

Sobre o assunto, veja-se: EMENTA: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODOS OU TÉCNICAS ESPECIAIS INDICADAS POR MÉDICO ASSISTENTE. PROFISSIONAL HABILITADO PARA A ESCOLHA DO TRATAMENTO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. 1. É abusiva a recusa do plano de saúde em fornecer o tratamento à parte apelada através de procedimento recomendado pelo médico especialista que acompanha o paciente. Isto porque compete ao médico, e não ao plano de saúde, eleger quais procedimentos/técnicas são necessários e adequados à cura/sobrevivência do segurado. 2. Estando comprovada a necessidade de tratamento multidisciplinar através de métodos especiais, não havendo cláusula específica a negar sua cobertura e cuidando-se, ademais, de exame necessário diante do quadro clínico do paciente, deve ser autorizada sua realização. 3. A Seção Cível, no julgamento do IAC na apelação cível nº 0018952-81.2019.8.17.9000, assegurou, em caráter vinculante, ao portador do Transtorno do Espectro Autista – TEA, beneficiário de contrato de assistência à saúde, com vigência anterior ou posterior à Lei nº 9.656/98 e independentemente do contrato ser adaptado ou não, cobertura integral, multidisciplinar e contínua, incluindo as chamadas terapias especiais (terapia ocupacional por integração sensorial, fonoaudiologia, psicomotricidade, musicoterapia, hidroterapia/fisioterapia aquática, equoterapia, psicopedagogia), sem restrições quanto aos métodos terapêuticos (ABA, BOBATH, HANEN, PECS, PROMPT, TEACCH e INTEGRAÇÃO SENSORIAL), seja no ambiente domiciliar e escolar, tudo conforme laudo do médico assistente. 4. Tendo em vista que a procura por profissionais não credenciados não decorre, em princípio, de mera opção do demandante, cabível o custeio e reembolso integral dos tratamentos pela Seguradora, conforme IAC acima mencionado. 5. **Quando o valor da cobertura indevidamente negada é imensurável no momento da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, assim ocorrendo nos tratamentos continuados ou por prazo indefinido, o critério para o seu arbitramento, seguindo a ordem de preferência estabelecida pelo STJ, deve ser o do valor da causa. 6. Contudo, conforme entendimento pacificado pelo STJ, no julgamento do REsp.1.850.512/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, como é o presente caso, se admite o arbitramento de honorários por apreciação equitativa** 7. Não obstante arbitrados por equidade pelo juízo a quo, sua fixação não está alinhada com o CPC, por ter sucumbência recíproca. Assim, deverão ser redistribuídos na mesma proporção delimitada para as custas. Tudo conforme o art. 86, do CPC: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. 8. Recurso parcialmente provido. Unânime. (TJPE, Apelação Cível 0001049-42.2023.8.17.2970, Rel. RUY TREZENA PATU JÚNIOR, Gabinete do Des. Ruy Trezena Patu Júnior (2ª CC), julgado em 11/10/2024). [Realcei]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, **nos termos do inciso I, do art. 487 do CPC, JULGO PROCEDENTE** o pedido para o fim de confirmar a tutela antecipada deferida, ficando a ré compelida a fornecer à autora o acompanhamento com assistente terapêutico em sala de aula (AT),

nos moldes da indicação médica, na rede credenciada, ou, caso inexistente, integralmente e diretamente ao prestador fora da rede credenciada, por tempo indeterminado, enquanto durar o tratamento da doença da qual é portadora, nos termos das teses fixadas no julgamento do IAC n° 0018952-81.2019.8.17.9000, pelo período de vigência do contrato entabulado com a ré e enquanto prescrito pelo médico assistente, devendo a parte autora proceder com o pedido administrativo correspondente, enviando a frequência e demais documentos necessários a comprovação da prestação do serviço.

Pela sucumbência, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ante o irrisório valor da causa.

P.I.

Ciência ao MP.

Transcorrido in albis o prazo recursal, verifique a Diretoria Cível se há pendência quanto ao pagamento das custas processuais por inércia da parte devedora (demandada), efetuem-se os cálculos das aludidas custas e remetam-se, por ofício, ao Comitê Gestor de Arrecadação, juntamente com cópia da presente sentença e da certidão do trânsito em julgado, observados os limites da Lei 14.731/12, como determina o § 3º do art. 27 da Lei 17.116/2020.

Em seguida, arquivem-se com as cautelas de praxe.

Recife, data da assinatura eletrônica.

Cátia Luciene Laranjeira de Sá

Juíza de Direito

*

Assinado eletronicamente por: CATIA LUCIENE LARANJEIRA DE SA
21/10/2024 14:47:04
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 185918968

24102114470399600000181331081

IMPRIMIR GERAR PDF